

Sur l'hyperactivité réactionnelle, c'est l'histoire de Monique qu'il faut interroger. À la demande du médecin du travail, je la reçois en urgence pour risque suicidaire. Depuis son embauche, Monique, 58 ans, est chargée de gestion dans une entreprise fabriquant des produits pour la préparation des médicaments. Les clients sont donc des industriels ou des distributeurs. Monique est divorcée, avec une fille à charge et, après son licenciement, a été contente de ce nouveau poste, se situant pas trop loin de son domicile.

Fusion-rachat en 1990. Son entreprise est désormais détenue par un groupe étranger. « Le travail s'est beaucoup

modifié. La hiérarchie mise en place est devenue plus exigeante dans la quantité de travail. Les objectifs étaient de plus en plus élevés et nous avions du mal à les atteindre. »

Monique me raconte qu'à son embauche elle était secrétaire de direction. Peu à peu, elle a acquis de l'autonomie, pris plus de responsabilités et a pu organiser son poste. Elle souligne que, de par son caractère, elle a un goût très prononcé pour l'organisation, pour la rapidité dans l'exécution des tâches, et le souci de se montrer particulièrement efficace. Ces traits particuliers, qui font les qualités d'une très bonne assistante de direction, se retournent souvent contre l'intéressée. J'attends de voir si son récit le confirmera.

Pendant quelques années, Monique, très motivée, ne mesure pas les heures supplémentaires à effectuer. Elle travaille avec passion. Mais, insidieusement, elle s'est mise à « ruminer » quand elle n'avait pas fini une tâche le vendredi soir. Elle s'est mise également à éprouver le sentiment constant de n'être jamais à jour, de devoir hiérarchiser sans arrêt de nouvelles urgences.

Peu à peu, Monique s'est réveillée toutes les nuits du week-end, et notamment celle du dimanche soir, remâchant ses priorités avant la reprise du lundi.

Elle décrit son patron comme particulièrement exigeant, ce qui renforçait sa propre exigence intérieure. « Il s'est montré de plus en plus dur. Il y a eu toute une succession de secrétaires qui ne supportaient pas la charge de travail. Par ailleurs, l'informatisation de notre activité a demandé une gestion supplémentaire. »

À ce stade de l'entretien, Monique se lance dans une description extrêmement calme et précise de ses tâches de travail : de la commande jusqu'à la facturation, en passant par la gestion de toutes les étapes intermédiaires. Au fil du temps, elle se voit submerger par un nombre toujours



croissant de commandes, des commandes de plus en plus compliquées, donc des étapes de gestion intermédiaires de plus en plus lourdes et de plus en plus complexes. En contrepartie, elle ne reçoit aucune aide supplémentaire en termes d'effectif et, surtout, aucune reconnaissance de la surcharge de travail.

Son patron analyse mal le travail réel de Monique. Il analyse plus volontiers son état psychologique, faisant l'impasse sur la place qu'y joue le travail.

Tandis que ce directeur est opiniâtrement engagé dans le développement financier de sa filiale afin d'en assurer la pérennité, Monique l'est tout autant dans la tenue rigoureuse du secteur des commandes. Voilà une belle rencontre entre deux perfectionnistes hyperactifs.

Mais la croissance de l'activité, l'ajout de structures, les surcharges de travail au moment des bilans semblent venir à bout de la santé de Monique. Elle dit avoir commencé à se révolter contre ceux qui ne donnaient pas les informations, essentiellement à partir du moment où elle a subi de plus en plus de critiques sur son travail.

À ce moment de son récit, assez bouleversée, elle hésite sur la chronologie, mais finit par situer le début de sa révolte autour de l'année 2000. Elle se met à répondre à son patron, mais elle se heurte à un mur : il nie la lourdeur de son travail et critique son perfectionnisme. « Il ne voulait jamais admettre l'excès de travail, me critiquait de plus en plus. »

Dans une première conception théorique, c'est le défaut d'imagination qui fait du sujet un hyperactif compulsif, dépendant de l'activisme pour calmer son angoisse, comme l'alcoolique dépend de l'alcool ou le toxicomane d'une drogue, pour maintenir son équilibre psychique.

Dans une seconde conception, l'hyperactivité est la conséquence des efforts déployés par le sujet pour assumer

des contraintes croissantes imposées par l'organisation du travail, tout en continuant de produire un travail de qualité. À partir d'un certain niveau d'intensité, le travail entre en concurrence avec la possibilité de penser.

Monique relate alors que son directeur lui demande de faire l'inventaire physique dans des entrepôts industriels. Il s'agit de partir en banlieue éloignée de son domicile à 8 heures du matin, de manipuler toute la journée les containers et de monter à l'échelle pour recenser les différentes références. Ces inventaires, qui se déroulent de surcroît dans des émanations de gaz d'échappement extrêmement toxiques, ne se terminent jamais avant 19 heures et, étant donné l'éloignement de ces sites, elle rentre extrêmement tard chez elle. Mais si jamais elle arrive au travail le lendemain avec une demi-heure de retard, elle se fait critiquer violemment.

C'est autour de ce déni de la surcharge progressive de travail qu'apparaît la détérioration des rapports entre son directeur et Monique. Elle souligne que, malgré ses demandes, elle ne deviendra jamais cadre et n'obtiendra aucune augmentation.

À partir de là, son récit raconte l'aggravation des différends relationnels, la dégradation de son caractère, l'irritabilité, la nervosité, l'agressivité. Il n'y a pas de différence visible entre un caractère « équilibré » et un caractère « pathologique » ou décompensé, si ce n'est l'augmentation quantitative des singularités caractérielles qui deviennent alors des symptômes.

Sur le plan clinique, je note que, outre les insomnies transitoires de la nuit du dimanche au lundi, s'installent peu à peu des ruminations obsédantes tous les week-ends, une tension nerveuse de plus en plus forte, due à l'envie de satisfaire à la fois son directeur et ses propres exigences



intérieures. Monique finit même par faire des cauchemars. Elle se sent de plus en plus mal.

Classiquement, son médecin généraliste lui prescrit antidépresseurs et somnifères. En mars 2002, elle est vue par son médecin du travail. Grâce à lui, son poste est modifié : elle fait moins d'administratif, un peu plus d'achats et est soulagée des commandes. Son patron lui confirme par écrit qu'il la décharge de certaines initiatives, mais se montre toujours impatient et l'accuse encore une fois d'être ralentie par son perfectionnisme. Qu'elle établisse des priorités, elle ira plus vite !

À son retour des congés de Pâques, son patron lui fait de nombreux reproches, sur ses vacances, sur son attitude avec les autres salariés, sur son travail où, selon lui, elle ne prend plus d'initiative. Pour lui montrer que c'est lui qui a pris la décision de lui retirer ces initiatives, Monique lui montre le mail qu'il a lui-même rédigé. Elle me dit qu'elle est soulagée d'avoir pu pointer les contradictions dans lesquelles son directeur la plaçait, car elle finissait par devenir folle dans cette ambiance de travail.

Les vacances d'été résorbent sa fatigue, elle arrête les antidépresseurs et reprend en septembre en se sentant mieux. Mais l'épuisement se réinstalle très vite. Son directeur continue à se montrer insatisfait, notamment sur les dates de congés qui deviennent, selon les dires de Monique, un véritable cauchemar : comme elle n'est pas remplacée, elle doit anticiper sur la charge de travail qu'elle va laisser, mais trouve à son retour une surcharge de travail qui efface bientôt tout le bénéfice du repos.

Le médecin du travail la revoit en novembre et note dans son dossier : « Tension professionnelle identique avec un patron qui semble toujours méconnaître la surcharge de travail. »

mon écroulement, je me jugeais minable, plus bonne à

Monique dit qu'ensuite elle ne se souvient plus. Les minutes, les heures, les jours, les mois passent. Elle a « la tête dans le guidon ». Elle commence à ressentir des douleurs de type tendinite aux coudes, aux genoux, aux épaules. Elle est très fatiguée au réveil, et les contractions sont telles qu'elle se retrouve un matin complètement bloquée.

À cette époque, elle se réveille plusieurs fois par nuit, alors même qu'elle prend encore des somnifères. Elle est toujours très fatiguée, sinon épuisée. Elle profite de sa pause déjeuner pour rentrer chez elle et quelquefois, sans même enlever son manteau, elle se couche et dort quelques minutes. Son médecin traitant augmente les antidépresseurs.

À cause de ses douleurs articulaires diffuses, elle est arrêtée quinze jours par son médecin. Son employeur lui adresse un avertissement.

Lorsqu'elle reprend, c'est pour éponger son travail et celui d'une collègue, en arrêt maladie elle aussi, et pour les mêmes raisons. Elle quitte le bureau après 20 heures, demande de l'aide, obtient une stagiaire qu'elle doit former et qui n'est compétitive qu'à la fin du stage.

Elle s'écroule et, cette fois, est arrêtée deux mois. Depuis quelque temps, elle pleure régulièrement. Monique me décrit un état de profonde détresse et un effet de relâchement, comme un élastique trop tendu qui revient en boomerang, sans contrôle : « Je ne mangeais plus, je ne me lavais plus, je restais prostrée dans mon lit sans bouger. Je ne répondais plus au téléphone et n'appelais personne. Je ne voyais plus comment sortir de la situation. C'était un tunnel noir, sans fin. Mon employeur m'a fait contrôler chez moi pendant mon arrêt, comme s'il ne croyait pas à la réalité de ma maladie. Je m'en voulais de mon écroulement, je me jugeais minable, plus bonne à



rien. Non, vraiment, je ne voyais pas d'issue. Sur le chemin de la boulangerie, je me suis mise à compter les passages à niveaux. Il y en avait quatre. Une illumination m'a traversée : je vais me tuer et ce sera fini ! Alors à chaque sortie, je minutais le passage des trains, je repérais les lieux les plus propices pour me précipiter sur les rails. Je me représentais cette fin comme une sortie bienheureuse. »

Dernier sursaut, dû pour une bonne part à la qualité de la relation avec le médecin du travail, Monique demande une consultation pour lui relater tout cela. Elle veut tenter une reprise de travail, ce que le médecin accepte mais « sous haute surveillance ». Le jour de son retour, dans le couloir, devant ses collègues, elle est crucifiée par son patron qui lui assène des reproches cinglants sur son absence et la désorganisation du travail qu'elle a entraînée. Il lui dit qu'il a pris cet arrêt maladie comme une insulte personnelle ! Du coup, il a supprimé sa prime d'ancienneté ! Monique est remise en inaptitude temporaire le jour même par le médecin du travail. Elle reparle de suicide. Le même médecin la « tacle » cliniquement en l'appelant tous les matins.

Je lui trouve un rendez-vous en urgence. L'épuisement est tel, les tendances suicidaires si fortes que je l'adresse à un correspondant psychiatre afin qu'il vérifie la pertinence des molécules chimiques actuellement prescrites par le généraliste. La possibilité d'une hospitalisation courte pourrait marquer la sévérité du tableau clinique, pour la patiente comme pour l'environnement professionnel.

À l'évidence, Monique pousse la résistance au-delà des limites de l'acceptable et, en face, son patron fait de même sans que ni l'un ni l'autre ne perçoive le toboggan noir sur lequel ils se sont engagés.

Le travail psychothérapique va s'axer sur l'analyse de la part personnelle de l'hyperactivité et sur la compréhension

du modèle organisationnel. Les rêves sont prolixes, témoignant d'une bonne structure bien mentalisée mais marquée du sceau traumatique : Monique fait des cauchemars : « Je suis emprisonnée dans une camisole de cuir qui m'immobilise », « Je suis clouée sur une planche et des crocs transpercent mes articulations... »

Bientôt, cette emprise sadique s'estompe au profit d'une conflictualité de bon aloi. Très vite, les imagos parentales sont convoquées comme des demandeuses de bonne conduite, de travail parfait, mais dans un climat de gentillesse.

Le perfectionnisme, le besoin de tout contrôler et l'hyperactivité dominant sa vie et l'empêchent de se détacher de son travail.

Au décours d'un long arrêt maladie qui débouchera sur une inaptitude à tout poste dans l'entreprise prononcée par le médecin du travail, Monique trouvera les mots pour décrire « la convocation d'un mécanisme infernal, impossible à arrêter, emportant le corps dans un rythme qu'aucune volonté consciente ne peut plus arrêter. Comme une bougie qui brûle, qui brûle, sans qu'on arrive à l'éteindre, et qui se consume jusqu'à sa disparition... Alors on ne voit plus d'autre solution que d'écraser la bougie ».

Nos athlètes de la quantité, parfaits rouages du productivisme demandé, s'excitent, puis s'usent, puis disparaissent, escamotés par la maladie, vite remplacés par d'autres. Certains décident de partir avec fracas.